

CAPÍTULO 9.9

Transfusión en Anemias

PERFIL EUNACOM 1.07.1.009

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

# Indicaciones de Transfusión en Anemia

Principio Clave

No se transfunde por el número, sino por los síntomas.

- La indicación es **Anemia: Generalidades**|anemia con síntomas severos:
- Isquemia cardíaca** (angina, IAM)
- Shock por anemia** (no por hipovolemia)
- Disnea de reposo** (hipoxia grave en reposo)

Cortes orientadores de Hb

| TABLA 9.9.1: HB VS PROBABILIDAD DE NECESITAR TRANSFUSIÓN |                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| HB                                                       | PROBABILIDAD DE NECESITAR TRANSFUSIÓN         |
| < 7 g/dL                                                 | Alta (la mayoría tiene síntomas severos)      |
| 7–10 g/dL                                                | Depende de la clínica (síntomas severos o no) |
| > 10 g/dL                                                | Muy rara (buscar otra causa del síntoma)      |

| EUNACOM CRITERIOS                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hb 6,9 con anemia ferropénica <b>bien tolerada</b> (solo disnea de esfuerzo) → <b>NO transfundir</b> → tratar con hierro. |

Producto a usar

| TABLA 9.9.2: SITUACIÓN VS PRODUCTO |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| SITUACIÓN                          | PRODUCTO                                             |
| Anemia (cualquier causa)           | <b>Glóbulos rojos concentrados</b> (no sangre total) |

| **Hemorragia puerperal** | **Sangre total** (necesita GR + factores de coagulación) |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 72 años con antecedentes de cardiopatía coronaria e infarto previo ingresa por neumonía. Se encuentra hemodinámicamente estable (PA 120/75, FC 80 lpm), sin angina ni disnea. El hemograma de ingreso muestra Hb de 7.4 g/dL."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Criterios Transfusionales de Glóbulos Rojos: en pacientes hospitalizados hemodinámicamente estables con antecedente de enfermedad cardiovascular, el umbral transfusional restrictivo recomendado por guías es Hb < 8.0 g/dL (y < 7.0 g/dL en pacientes sin cardiopatía). 1 unidad de Concentrado de Glóbulos Rojos (CGR) aumenta aproximadamente 1 g/dL la Hb y 3% el hematocrito en un adulto de 70 kg.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La indicación de transfusión es anemia severa con síntomas severos: isquemia cardíaca, shock o disnea de reposo
- No hay un valor de corte absoluto de hemoglobina para transfundir
- Bajo Hb 7: muy frecuente que se transfunda. Sobre Hb 10: muy raro
- Entre Hb 7–10: depende de la clínica (presencia de síntomas severos)
- Se transfunde con concentrado de glóbulos rojos como regla general
- Excepción: hemorragia puerperal se transfunde con sangre completa (aportar factores de coagulación)

## EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRANSFUSIÓN EN ANEMIAS)

## PREGUNTA 1

Paciente con anemia ferropénica crónica, hemoglobina de 6,8 g/dL, que refiere cansancio al caminar pero se encuentra hemodinámicamente estable, sin disnea de reposo. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Transfundir concentrado de glóbulos rojos de urgencia
- B)** Transfundir sangre completa
- C)** Tratar con hierro oral sin transfundir
- D)** Iniciar eritropoyetina
- E)** Solicitar biopsia de médula ósea

## PREGUNTA 2

¿En cuál de las siguientes situaciones se transfunde con sangre completa en lugar de concentrado de glóbulos rojos?

- A)** Anemia hemolítica aguda grave
- B)** Hemorragia puerperal
- C)** Anemia ferropénica con Hb de 5 g/dL
- D)** Coagulación intravascular diseminada
- E)** Traumatismo con shock hipovolémico

## PREGUNTA 3

Paciente con hemoglobina de 11 g/dL que presenta disnea de reposo. ¿Cuál es la conducta más apropiada respecto a transfusión?

- A)** Transfundir de inmediato
- B)** Buscar otra causa de la disnea ya que es muy raro que una Hb >10 cause síntomas severos
- C)** Transfundir solo si la Hb baja de 10
- D)** Iniciar eritropoyetina
- E)** Solicitar pruebas de hemólisis

## RESUMEN: TRANSFUSIÓN EN ANEMIAS

Esta clase cubre las indicaciones de transfusión en el contexto de anemia. La indicación es una anemia severa con síntomas severos: isquemia cardíaca, shock por anemia o disnea de reposo. No existe un valor de corte absoluto de hemoglobina para transfundir. Se describen dos puntos de referencia: bajo hemoglobina de 7 g/dL es muy frecuente que se transfunda (suele haber síntomas severos), y arriba de 10 g/dL es muy raro que la anemia cause síntomas severos. Entre 7 y 10 depende de la clínica. La transfusión se realiza con concentrado de glóbulos rojos como regla general. La única excepción es la hemorragia puerperal, donde se transfunde con sangre completa para aportar también factores de coagulación.